

แนวทางการคัดกรองและจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์มารับบริการฝากครรภ์

ซักประวัติ

ตรวจร่างกาย

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

แบ่งระดับความเสี่ยง

Low Risk

- ไม่มีความเสี่ยง

ANC : รพสต.

โดย

พยาบาล/จนท.

High Risk 1

- เคยมีทารกตายในครรภ์หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก)
- เคยคลอดบุตรน้ำหนัก < 2,500 กรัม หรือ > 4,000 กรัม
- อายุ < 17 ปี หรือ อายุ ≥ 35 ปี (นับถึง EDC)
- ประวัติครรภ์เป็นพิษในครรภ์ก่อน หรือ ครรภ์เป็นพิษในครอบครัว
- ประวัติเบาหวานในครรภ์ก่อนหรือเบาหวานในครอบครัว

- เลือดออกทางช่องคลอด
- BMI ก่อนตั้งครรภ์ < 18.5 กก./ตรม. หรือ ≥ 23 กก./ตรม.
- O2 sat < 95%
- ส่วนสูงน้อยกว่า 145 ซม.
- ตรวจร่างกายทั่วไปพบความผิดปกติโดยพยาบาลฝากครรภ์

ANC : รพช.

โดยแพทย์/พยาบาล

High Risk 2

- ครรภ์ที่ 5 เป็นต้นไป
- เคยแท้ง 3 ครั้ง ติดต่อกันหรือมากกว่า
- ประวัติแท้งในไตรมาสที่ 2
- ประวัติคลอดก่อนกำหนด (< 37 wks.)
- ประวัติความผิดปกติทางรีเวช เช่น ผ่าตัดปากมดลูก เนื้องอกมดลูก
- เคยผ่าตัดคลอดหรือผ่าตัดมดลูก
- เคยคลอดบุตรมีโครโมโซมผิดปกติ หรือมีประวัติคลอดทารกพิการแต่กำเนิด
- โรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไทรอยด์, โลหิตจาง HIV, โรคจิตเวช

- BMI ก่อนตั้งครรภ์ 30- 40 กก./ตรม
- Twin DCDA
- ความดันโลหิต Diastolic ≥ 90 mmHg หรือ Systolic ≥ 140

- Rh Negative
- HbSAg positive
- Syphilis positive
- HIV positive
- Thalassemia disease

ANC : รพช.แม่ข่าย/รพท

โดย สติแพทย์

High Risk 3

- โรคหัวใจ WHO 2 ขึ้นไป
- โรคไต, Antiphospholipid syndrome, SLE

- BMI ก่อนตั้งครรภ์ ≥ 40 กก./ตรม.
- Twin MCDA, MADA, Triplet ขึ้นไป
- ผลตรวจทารกในครรภ์ผิดปกติ (Abnormal U/S)
- มีก้อนในอุ้งเชิงกราน
- ภาวะรกเกาะแน่น
- ตรวจพบโรคทางอายุรกรรมที่เกินศักยภาพพ.แม่ข่าย
- โรคจิตเวชที่ควบคุมไม่ได้

- Severe anemia (Hct < 28% or Hb < 9)
- thrombocytopenia
- NIPT or Quad test high risk
- ส่งตรวจ PND (หลังตรวจแล้ว ถ้าไม่พบความเสี่ยงส่งกลับฝากครรภ์สถานพยาบาลเดิม)

ANC : รพ จังหวัด./รพศ.

โดย สติแพทย์/MFM